

PATOLOGÍAS DEL OÍDO MEDIO

K.N. Montaña Rueda, N. Bilbao Garitagoitia, J. Prada Pendolero.

OTITIS MEDIA AGUDA (OMA)

Introducción

Patología frecuente, precedida de historia de cuadro catarral o infección de vías respiratorias altas previas, principal causa de otalgia en los niños, se presenta a cualquier edad, pero es más frecuente en niños entre los 3 meses y los 3 años debido a que la trompa auditiva es inmadura tanto estructural como funcional. Germen: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella Catarrhalis.



Otitis media aguda

Diagnóstico

El diagnóstico es clínico, tiene un inicio abrupto y reciente de otalgia con hipoacusia transmisiva y sensación de plenitud. Según la evolución del cuadro existen 2 presentaciones otoscópicas:

- Membrana timpánica abombada y eritematosa sin otorrea (OTALGIA INTENSA POR DISTENSIÓN TIMPÁNICA).
- Perforación timpánica reciente, con otorrea serosanguinolenta (OTALGIA DE MENOR INTENSIDAD).

En general en la otoscopia se aprecia membrana timpánica muy enrojecida o abombada, clínicamente puede presentar otalgia/otodinia intensa, hipoacusia, acúfenos, fiebre y malestar general. Si hay perforación timpánica sin complicaciones la resolución de la perforación timpánica suele ser espontánea y completa en pocas semanas. Si no se resuelve la perforación timpánica estaremos frente a una OTITIS MEDIA CRÓNICA, pudiendo ser:

Simple: perforación simple, central con fondo de mucosa de la caja sano.

Colesteatomatosa: perforación marginal, normalmente posterosuperior con fondo de mucosa de la caja con presencia de escamas blancas o granulaciones. Es ambos casos (simple o colestomatosa) el tratamiento requiere cirugía programada: miringoplastia (forma simple) y timpanoplastia (forma colestomatosa).

Tratamiento

- **Antibiótico:**

- Amoxicilina 500mg – 1g: 1c/cada 8h durante 7 días.
- Amoxicilina Clavulánico 875/125mg: 1cada 8 horas durante 7 días.
- Cefuroxima (Zinnat, Nivador o Selan) 500mg cada 12h durante 6 días.
- Si alergia a penicilina: Claritromicina (Klacid, Bremon) 500mg 1 cada 12h durante 10 días o Azitromicina 500mg cada 24 horas 3 días.
- Si otorrea: añadir gotas óticas: colircusi gentadexa 3-4 gotas cada 8 horas 7 días o Cetraxal plus 3-4 gotas cada 12 horas 7 días.

- **AINES:**

Dexketoprofeno 25mg 1 cada 8h durante 5 días o

Ibuprofeno 600mg 1 cada 8h durante 5 días.

NOTA: Descartar Complicaciones. AVISAR A ORL!

- MASTOIDITIS: edema con borramiento de surco retroauricular o fluctuación por absceso. “Urgencia médico-quirúrgica”
- LABERINTITIS: OMA asociada a vértigo de características periféricas.
- PARÁLISIS FACIAL.
- MENINGITIS: OMA + clínica neurológica

Bibliografía

- Cummings C. Cummings otolaryngology head & neck surgery. Philadelphia, Pa: Elsevier Mosby. 2017.
- Lorenzo Monasta, Luca Ronfani, Federico Marchetti, Marcella Montico, Liza Vecchi Brumatti, Alessandro Bavcar Burden of Disease Caused by Otitis Media: Systematic Review and Global Estimates PLoS One., 7 (2012), pp. e36226.